Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 29ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº 0091591-40.2022.8.17.2001

AUTOR: DALIA MUTCHNIK

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de *"Ação de obrigação de fazer c/c indenização pos danos morais com Pedido De Tutela De Urgência"* ajuizada por **DALIA MUTCHNIK** em face de **CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL**, devidamente qualificados na inicial.

Requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegou que mantém vínculo contratual com a operadora do plano de saúde e que está em dia com o pagamento das mensalidades.

Afirmou que apresenta quadro de intensa e incapacidade como anedonia dores em todo o corpo, cefaleia, falta de motivação para viver, angustia, inapetência, alteração do padrão de sono e sentimento de culpa, tendo sida diagnosticada com depressão recorrente grave e resistente ao medicamento.

Informa ainda que, baseando-se nas escalas de depressão e ansiedade, apresenta pontuações altíssimas (respectivamente 28 e 37) mesmo com o uso da medicação.

Diante das patologias que acometem a autora, foi prescrito por médico assistente 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), sendo necessárias mais sessões caso o tratamento realizado não seja suficiente, conforme laudo médico sob ID 113149697.

Requereu que o plano de saúde fosse compelido a custear integralmente o tratamento mencionado acima fora da rede credenciada do réu, com o médico assistente e a equipe que já acompanha a autora, para salvaguardar a saúde da demandante.

No mérito, a confirmação da tutela de urgência e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00. Juntou Procuração (ID 113148065), declaração de hipossuficiência financeira (ID 113148069) e demais documentos.

Manifestação do réu sobre o pedido de tutela de urgência (ID119503349) alegando não haver cobertura contratual; não constar o procedimento de EMT no rol da ANS; ser uma entidade de autogestão.

Concedida a antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento (id 131486453) para determinar que o plano de saúde autorize o tratamento indicado no laudo médico, de 30 (trinta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, sob pena de multa diária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Parte ré apresentou contestação (ID 121014380), alegando, preliminarmente: (i) impugnação à gratuidade de justiça; (ii) incorreção no valor da causa. No mérito, em síntese, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; ausência de danos morais.

Disse ainda que o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não está contemplado no rol da ANS, não sendo objeto de cobertura pelas Condições Gerais do Contrato.

Aduziu que as cláusulas contratuais, bem como a legislação pertinente ao produto contratado pela parte demandante são claras no sentido de que devem se dar nos termos do contrato. Ainda, arguiu a inexistência dos danos morais pleiteados. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Réplica no ID 134954585, reitera os termos da inicial, e pontua que a o EMT é o mais indicado e de melhores resultados para o tipo de enfermidade que acomete a autora já que esta não obtém resultados satisfatórios por meios de medicações.

Intimada para especificarem outras provas, as partes informaram não ter novas provas a produzir (ID 134954585 e 133135831). Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo à decisão.

O feito apresenta-se suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC, por não haver necessidade de dilação probatória, pelo que se dispensa a produção de provas requerida pela parte ré.

Inicialmente, passo à análise das preliminares arguidas pela ré.

No que diz respeito à **impugnação ao pedido de justiça** gratuita, entendo que não merece prosperar, haja vista que, nos termos do § 2º, do artigo 99, do CPC, o pedido de justiça gratuita somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da

gratuidade, presumindo-se, à luz do disposto no § 3º, do mesmo Diploma Legal, como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, diante da declaração de hipossuficiência financeira devidamente assinada e datada pela parte autora (ID (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3460917&ca=f24a606c2baf4c8478070329ee0936dc1a755401929a222c241a0b e dos demais elementos que compõem o feito, considero como satisfeitas as exigências legais para a concessão do benefício, não se desincumbindo o réu de trazer ao feito prova em contrário. **Rejeito**, pois, a preliminar suscitada.

No que se refere à **impugnação ao valor da causa**, sabe-se que a toda causa deve ser atribuído um valor certo e, regra geral, a quantia deve corresponder ao proveito econômico a ser obtido pelo demandante. Nos casos em que não é possível aferir o proveito econômico almejado no momento da propositura da ação, admite-se a atribuição de valor à causa por mera estimativa. Diante do valor de R$50.000,00 atribuído à causa, entendo pela estimativa do valor ao tratamento pleiteado como sendo R$40.000,00, já que há pedido de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. **Rejeito** também a segunda preliminar suscitada.

Passo à análise das questões de mérito.

No caso em tela, pretende a parte autora a autorização do tratamento com o médico assistente inicialmente por 30 sessões, e ainda o pleito indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

A controvérsia ora posta cinge-se a determinar se a negativa de cobertura perpetrada pela operadora de plano de saúde demandada é legítima ou não, bem como se houve dano moral decorrente da resistência ao custeio do procedimento prescrito para o tratamento da depressão grave e demais patologias que acometem a autora.

Ab initio, cumpre destacar que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, contudo, sendo a demandada entidade de autogestão, as disposições do CDC são inaplicáveis a suas relações com os segurados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado através do enunciado da Súmula 608: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Não obstante a inaplicabilidade da lei consumerista, o negócio jurídico se submete às disposições do Código Civil e da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), devendo sempre preponderar a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Importa ressaltar, ainda, que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde dos contratantes.

Desta feita, é descabido qualquer argumento de que o procedimento solicitado pelo médico assistente não consta no rol da ANS, até porque o referido rol, pela própria essência dos contratos de plano de saúde, prevê uma cobertura mínima, sendo meramente exemplificativo, e não exaustivo, corroborado pelo Art.10, §§12 e 13, da Lei nº 9.656/1998, com redação conferida pela Lei nº 14.454/2022.

De acordo com o laudo médico (ID 113149697), “Associado a quadro de humor, apresenta queixas álgicas frequentes, contribuindo com sua incapacidade física e mental, além do agravamento do quadro depressivo. Apresenta efeitos adversos bastante desconfortáveis com as medicações, não trazendo sua melhora e ainda contribuindo em certos aspectos com a piora de seus sintomas. No momento em uso de Duloxetina 90 mg/dia, mantendo sintomatologia grave, intensa e incapacitante como anedonia, dores em todo o corpo, cefaleia, falta de motivação para viver, angústia, inapetência, alteração do padrão de sono, sentimento de culpa.”

Trata-se de ação ordinária na qual a autora alega ter sido prescrita a técnica de neuromodulação (Estimulação Magnética Transcraniana).

Na hipótese deduzida nos autos, a requerente busca autorização/custeio para tratamento de estimulação magnética intracraniana para a moléstia que a acomete, além da condenação da parte ré no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Portanto, a questão central posta no presente feito consiste em averiguar se a parte ré tem, ou não, a obrigação de custear a internação psiquiátrica e Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), junto a prestador que já a acompanha para que seja tratada a patologia da autora.

Há nos autos laudo médico o qual relata que a autora tem histórico de ansiedade, depressão grave resistente a tratamento medicamentoso, devendo, segundo o médico que a assiste, ser submetida à tratamento psiquiátrico e multiprofissional regular com EMT, sendo certo que a falta de tal tratamento pode acarretar piora na saúde mental da paciente/autora.

Por outro lado, da contestação exsurge a negativa ao tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), sob o fundamento de que inexiste cobertura contratual para o tratamento com EMT, por não estar previsto no Rol de Procedimentos de Cobertura Obrigatória da ANS.

Quanto à negativa ao tratamento EMT, visto que a negativa ao tratamento se sustentou no Rol da ANS, sobre a matéria, os Tribunais pátrios firmaram entendimento majoritário no sentido de que o aludido rol tinha caráter meramente exemplificativo, constituindo referência das coberturas mínimas obrigatórias, mas não excluindo outras que se faziam necessárias, por expressa indicação médica, para o tratamento de doença coberta contratualmente. Ou seja, se a doença é coberta contratualmente, o seu tratamento - de acordo com a indicação médica - também deve ser. Neste sentido, cita-se julgado proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

> **Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, realizado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma**. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1981303/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, **julgado em 11/04/2022**, DJe 19/04/2022).

Posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade do Rol da ANS, contudo, com algumas ressalvas, especialmente quando demonstrada a inexistência de substituto terapêutico, considerando o quadro clínico da

paciente e a evolução da doença, mesmo com outros tratamentos.

Por oportuno, transcrevo o que restou definido pela 2ª Seção do STJ:

> 1) O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;
> 2) A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
> 3) É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
> 4) Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que **(I)** não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; **(II)** haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; **(III)** haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e **(IV)** seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva *ad causam* da ANS.

Para além disso, reproduzo o que restou consignado no julgamento do EREsp 1886929/SP acerca do tratamento *sub oculis* – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT):

> EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.
> (…)

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide **e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos**.

13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado.

14. Embargos de divergência a que se nega provimento

(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Para pôr fim às oscilações jurisprudenciais, recentemente foi sancionada a Lei nº 14.454/2022, a qual estabelece critérios que determinam a cobertura de exames ou tratamentos não incluídos no rol de procedimentos do sistema de saúde suplementar, **desde que comprovada a sua eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**, o que, do laudo médico de ID 113149697, infere-se ser a hipótese dos autos, *in verbis*:

> “Por tais motivos se enquadra em diagnóstico de depressão grave resistente ao tratamento medicamentoso necessitando de sua associação com o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana com urgência. O mesmo visa otimizar o tratamento em voga, com o intuito de remissão dos sintomas e melhoria na sua funcionalidade e qualidade de vida.”

Portanto, configuram-se atendidos os critérios estabelecidos no parágrafo 13, do artigo 10, da Lei 9.656/98, inseridos pela Lei 14.454/2022, *in verbis*:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de

Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)
(...)
§ 13. **Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que**: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)
I - **exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)

Diante do exposto, não se mostra razoável a recusa de custeio efetuada pela seguradora, mormente quando a terapêutica pretendida se perfaz em tratamento mais adequado para tratar doença listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, da OMS.

Para além disso, em conformidade com a jurisprudência do STJ, *somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente, não estando a seguradora habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor* (**STJ** - REsp: 1972051 SP 2021/0368835-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, **Data de Publicação: DJ 01/07/2022**)

Ademais, como dito pelo Des. Cândido Saraiva, é sobre o médico assistente que recai a responsabilidade penal e civil do diagnóstico, tratamento e medicação indicada ao paciente (TJ-PE - APL: 4372841 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 01/02/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017).

Sobre a matéria, colaciono recente julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA**. APLICAÇÃO. SÚMULA Nº DO STJ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ROL TAXATIVO ANS. INOVAÇÃO

RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Terceira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que **não cabe à operadora de plano de saúde eleger qual o procedimento a que deve ou não se submeter o beneficiário, indicação que cabe exclusivamente ao médico de confiança do paciente.** 3. Quanto ao ponto, a decisão agravada não aplicou a Súmula nº 7 do STJ, razão pela qual o seu afastamento esbarra na falta de interesse recursal. 4. Porque a alegação de que a OPERADORA não está obrigada a custear tratamento não previsto no rol da ANS não foi suscitada em recurso especial, se mostra inviável que seja discutido em agravo interno, por configurar indevida inovação recursal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1807169/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe **28/05/2021**)

Assim, reconhecida a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, cabe avaliar se existe o dever de custeio integral deste atendimento em estabelecimento não credenciado.

A legislação pátria autoriza o tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a situação de emergência/urgência cumulativamente à constatação de inviabilidade/impossibilidade da prestação do serviço pela rede referenciada, a ser constatada em cada caso.

O laudo médico emitido em 08/01/2022, expressamente consigna ser necessário o tratamento em regime de urgência. Consta a necessidade de realização de ao menos 30 sessões de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRIANA (EMT), em conjunto com o acompanhamento psiquiátrico.

Ainda, a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL não indicou prestadores na contestação, não tendo a ré comprovado estabelecimentos credenciados que estejam aptos a ofertar o tratamento da autora – Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e tratamento psiquiátrico - prova documental que era sua incumbência produzir, nos termos do art. 373, II, c/c art. 434, ambos do CPC.

Uma vez que no caso em testilha a operadora de saúde não se desincumbiu de comprovar, no curso da demanda, a existência de profissionais ou estabelecimentos credenciados habilitados a prestar o tratamento psiquiátrico e a Estimulação Magnética Transcraniana – EMT à autora, deve a demandada arcar integralmente com os custos do tratamento junto a prestador indicado pela beneficiária, a sua livre escolha.

Assim, no que tange à utilização da técnica de neuromodulação - Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) - cabe à ré custear integralmente o tratamento.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais**,** este também é procedente. Conquanto o mero descumprimento contratual não gere, por via de regra, danos morais, o caso dos autos demonstra merecer tratamento diferenciado. A autora estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que acometido de doença grave, necessitando submeter-se ao tratamento na modalidade requerida.

Suportando a demandante não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se a custear, resta claro que seu abalo psicológico não se limitou a mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu o demandante.

O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA FINANCEIRA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO POR MÉDICO CREDENCIADO (CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA). DANO MORAL CONFIGURADO. (...) DECIDO. 2**. Merece guarida o reclamo. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de procedimento cirúrgico, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário**. A propósito, confiram-se as ementas de precedentes que guardam similitude com a hipótese dos autos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. VIDEOLAPAROSCOPIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 674.251/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18.06.2015, DJe 23.06.2015) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA PELO MÉTODO DA VIDEOLAPAROSCOPIA. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL INDENIZÁVEL(...). **A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário**. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05.03.2015, DJe 11.03.2015) (...) Desse modo, afigura-se impositivo o restabelecimento da sentença de procedência, tendo em vista, ademais, a razoabilidade do quantum indenizatório fixado, que encontra amparo na jurisprudência desta Corte que recomenda a utilização do método bifásico para o correto balizamento do valor devido à título de indenização por danos morais (REsp 1.445.240/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 22.11.2017). 3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de restabelecer os termos da sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de junho de 2018. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (STJ - REsp: 1626104 SP 2016/0241309-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/08/2018)

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o tempo pelo qual a autora permaneceu em desgaste físico e emocional, nos termos do art. 944 do CC, razão por que arbitro a indenização em **R$ 5.000,00 (cinco mil reais).**

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a tutela de urgência concedida, e ainda:

A)JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para determinar que a parte ré autorize e arque com os custos do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), diretamente ao prestador não credenciado – com a equipe do médico assistente– nos termos do laudo médico de ID 113149697.

B) Condeno a parte ré ao pagamento de indenização no valor de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais),** em favor da parte autora, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente de acordo com a tabela do ENCOGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC.

Ante a sucumbência, **condeno** a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (danos morais e obrigação de fazer), nos termos do art. 85, §2º do CPC c/c Súmula 199 do TJPE, com atualização monetária a partir desta sentença.

Caso haja recurso de apelação, **intime-se** o apelado para apresentar contrarrazões e, seguidamente remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, data de validação.

JOSÉ JÚNIOR FLORENTINO DOS SANTOS MENDONÇA

Juiz de Direito

lp

Assinado eletronicamente por: JOSE JUNIOR FLORENTINO DOS SANTOS MENDONCA
19/09/2023 09:25:54
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 144775325

23091909255476100000141397426

IMPRIMIR GERAR PDF